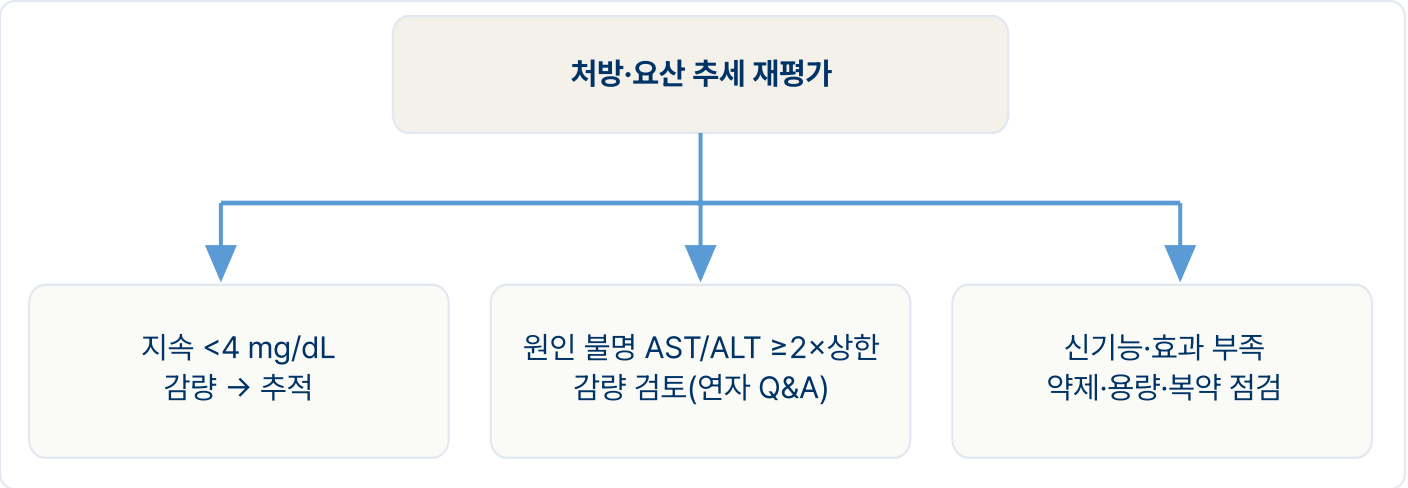
통풍 약 처방 재평가

신기능·간수치·요산 추세·발작을 함께 기록



김용길 연자 Q&A · 요산 과도 저하

목표 4~6 mg/dL. <4 mg/dL가 지속되면 먼저 감량하고 추적합니다. 금식·영양불균형의 일시 저하는 주기적으로 재검합니다. 감량 뒤에도 <4 mg/dL가 지속되면 환자와 상의해 중단을 검토하되 갑작스러운 중단의 발작 위험을 고려합니다.

! 김용길 연자 Q&A · 간수치 상승

정립된 절단값은 없다고 전제했습니다. 높은 AST/ALT는 정상 회복 후 시작하고, 복용 중 원인 불명으로 정상상한의 ≥2배 상승하면 febuxostat 감량을 시도할 수 있다는 의견입니다. 중단은 발작 위험 때문에 신중히 판단합니다.

신기능·효과 부족

eGFR·최근 변화, 투약량·복약·식이·체중, 혈청 요산과 발작·결절을 함께 봅니다. 저용량부터 점진 증량하며, 기존 ULT 복용 중 발작에는 약을 유지하고 급성기 항염 치료를 더합니다.

신기능·안전성에 따른 약 선택

강의의 약제 프로필과 모니터링

저용량 시작·유전자

Allopurinol ≤100 mg/day, CKD ≥3기는 더 낮게 시작합니다. Febuxostat ≤40 mg/day에서 점진 증량합니다. 한국인 HLA-B*5801과 AHS 연관을 강조했고, 강의 소개 고시 제2021-206호는 ULT가 필요한 모든 통풍 환자에서 allopurinol 최초 투여 전 검사를 인정한다고 설명했습니다.

약제 프로필

Allopurinol/febuxostat: 요산 과다생성(소변 >700 mg/day), >60세, CKD ≥3기·결석·결절에서 선택. Benzbromarone: 배설저하·<60세·신기능 보존·결석 병력 없음에서 소개했습니다. Thiazide 이뇨제는 가능하면 교체, losartan은 우대하고 심혈관 예방 aspirin을 통풍 때문에 일부러 중단하지 않습니다.

김용길 연자 Q&A · eGFR 30~59

NSAIDs/콜히친의 예방 병용이 어렵고 ≥3개월 스테로이드도 부작용 우려가 크므로 ULT를 저용량에서 1개월 간격으로 서서히 올리는 방법을 제안했습니다. 수개월 allopurinol 복용 중 무부작용이면 HLA 검사의 실효성은 낮지만 향후 신기능저하·고용량에서는 도움될 수 있다고 답했습니다.

Febuxostat 심혈관 위험

심장질환·뇌졸중 병력의 위험/이득을 고려하고 흉통·호흡곤란·이상 심박동·신체 저림·갑작스러운 두통은 즉시 진료하도록 설명합니다. CARES와 대규모 실제진료 연구의 결과 차이, 고용량·NSAID 교란 가능성을 함께 소개했습니다. 임의중단은 피합니다.

치료 불충분·유지·감량

아래 약 조정은 김용길 연자 Q&A의 제안

요산이 충분히 내려가지 않을 때

신기능이 정상이라면 benzbromarone 교체 또는 losartan 병용을 고려합니다. Febuxostat 80 mg/day로 대부분 조절되므로 조금 높은 경우 식단·체중부터 조정하고, 부족하면 120 mg/day 증량을 시도할 수 있다고 답했습니다. Allopurinol 병용 및 febuxostat+benzbromarone 병합은 권하지 않았습니다.

감량·추적 방식

격일보다 하루 1회 감량을 추천했습니다. 요산 ≤4 mg/dL가 유지되면 20 mg으로 감량이 가능하고, 감량 후 재발 없이 저요산혈증이 지속되면 상의 후 중단을 시도할 수 있다고 답했습니다. 안정 시 요산 혈액검사는 6개월 간격을 권했습니다.

강의 · ULT 시작 대상과 예방

결절 ≥1개·영상 손상·연 ≥2회 발작에 강하게 권고, 연 <2회는 상의합니다. 첫 발작은 CKD ≥3·SU >9 mg/dL·결석에서 고려합니다. 초기 3~6개월 예방 콜히친 0.6~1.2 mg/day, 한국인 저용량 0.6 mg/day의 효과를 소개했습니다. 재발 예방을 위한 무기한 유지가 기본입니다.

무증상 고요산혈증 · 설명의 범위

강의 본론은 통풍·신장·심혈관 예방만을 위한 무증상 투약을 권하지 않았습니다. 연자 Q&A에서는 원인 불명 신기능저하/고령에서 신기능 보호 목적 고려 의견도 제시했습니다. 통풍 병력 없는 CKD 연구와 통풍 환자 CARES 사후분석의 결과를 구분해 설명했습니다.